

Monotropizm i jego sieć komorbidności: bezpośrednie i pośrednie linki do warunków behawioralnych, psychiatrycznych i neurodevelopmentalnych

Cytowany przegląd badawczy.

Podsumowanie

Monotropizm (Murray, Lawson & Lesser, 2005) jest teorią autystycznej uwagi, która ramuje autyzm jako różnicę w *alokacji zasobów*: monotropowy umysł koncentruje zasoby przetwarzania w małą liczbę wysoko aktywowanych „tuneli uwagi”, zostawiając mniej zasobów dla kanałów obwodowych. Narzędzie samooceny z 2023 — **Monotropism Questionnaire (MQ)** — dostarcza pierwszej walidacji empirycznej, pokazując, że ludzie autystyczni i z ADHD oceniają znacząco wyżej niż kontrole nie-autystyczne/nie-ADHD [1][2][3]. Blisko spokrewniony model recenzowany, konto **atypowej alokacji zasobów** Goldknopfa, argumentuje, że ta sama wąska-intensywna uwaga może powiązać sensoryczne, społeczne, eksekutywne i motoryczne cechy autyzmu — ostrzegając, że jest „najprawdopodobniej czynnikiem u ludzi autystycznych z silnymi symptomami sensorycznymi”, nie jedyną przyczyną [4].

Bo monotropizm jest teorią *jak zasoby są wydawane*, plausible rozlewa się na wiele domen. Uczciwy obraz jednak dzieli się na trzy poziomy:

- **Poziom 1 — Bezpośrednie, empirycznie poparte linki.** Nakładanie autyzm–ADHD („AuDHD”) jest najsilniejsze: MQ pokazuje, że monotropowa uwaga jest podwyższona w *obu* warunkach, reframując

„monotropic split” (konkurujące lub niestabilne tunele) jako realny, mierzalny fenotyp uwagi [2][3][5]. Nakładania na poziomie mechanizmu — atypowa **interocepcja** i **dyseksekutywna dysfunkcja** — są dobrze udokumentowane i pomagają wyjaśnić downstream'owe problemy z jedzeniem, bałaganem i unikaniem [6][7][8].

- **Poziom 2 — Pośrednia, współdzielony-mechanizm komorbidność.** Autyzm znacząco nakłada się z **anoreksją/restrykcyjnym jedzeniem** i **OCD**. W każdym przypadku komorbidność jest realna i replikowana, ale *najlepiej udokumentowanym* pomostem jest współdzielony mechanizm (interocepcja; przetwarzanie ego-syntoniczne vs ego-dystoniczne) raczej niż monotropizm specyficznie [6][9][10].
- **Poziom 3 — Plauzybilna ekstrapolacja lub sporne konstrukty.** Niektóre linki w popularnych ramach — „doom piles” jako monotropowe niepowodzenie trwałości obiektu, agorafobia jako pierwotny wynik monotropowy, **PDA** jako odrębny profil — spoczywają na słabszej lub spornej evidencji i powinny być traktowane jako hipotezy, nie ugruntowane fakty [11][12][13].

Przez całą drogę powracający temat: wiele zachowań, które wyglądają jak odrębne „zaburzenia”, lepiej czyta się jako **kognitywny koszt wąskiego systemu uwagi kolizjonującego z polytropowym światem** — ale tylko niektóre z tych odczytów zostały bezpośrednio przetestowane.

1. Podstawy: czym jest monotropizm i jak solidny jest

Monotropizm proponuje, że umysły różnią się w tym, jak rozdzielają zasoby uwagi. Umysł **polytropowy** utrzymuje wiele kanałów zainteresowań aktywnych na raz (szeroki, płytki, łatwe przełączanie); umysł **monotropowy** leje zasoby w kilka intensywnie aktywowanych „tuneli uwagi” (wąski, głęboki, trudny do przełączenia) [1][3]. Twórcy — Dinah Murray, Wenn Lawson i Mike Lesser — zaprezentowali po raz pierwszy ideę na konferencjach Durham o autyzmie od 1992 i sformalizowali ją w 2005, argumentując, że wyjaśnia cechy autystyczne (specjalne zainteresowania, potrzeba identyczności, dystres w przejściach, fokus na detalu) lepiej niż modele tylko-deficytowe [1][14].

Jego status naukowy zmienił się w ostatnich latach:

- Jest **empirycznie mierzalny**. MQ (Garau et al., 2023) to 47-item narzędzie samooceny testowane na 1.110 uczestników (756 autystycznych, 354 nie-autystycznych). Uczestnicy autystyczni i z ADHD ocenili znacząco wyżej niż kontrole [2][3].
- Ma **recenzowanego mechanistycznego kuzyna**. Model „atypowej alokacji zasobów” Goldknopfa (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operacjonalizuje intuicję: w autyzmie zasoby uwagi są **zwięźzone** (na mniej/mniejsze obszary, modalności i etapy przetwarzania, czasem intensywniej) i/lub **zmniejszone** w ogólnej pojemności — ramy, które explicitnie wiążą język, kognicję społeczną, sensoryczną/uwagową atypikalność i eksekutywne/motoryczne różnice [4].
- Siedzi **obok, nie zamiast**, innych teorii kognitywnych (Teoria Umysłu; słaba spójność centralna / styl zorientowany na detal (Happé & Frith, 2006); dyseksekutywna dysfunkcja) [4][15].
- Jest jeszcze **modelem, nie biomarkerem**. Goldknopf jest explicitny, że jest to jeden czynnik spośród kilku, „najprawdopodobniej” salientny u ludzi autystycznych z silnymi symptomami sensorycznymi [4]. Murray i współpracownicy podobnie ramują monotropizm jako unifikującą *lens*, nie kompletną etiologię [1][14].

Implikacja dla reszty tego przeglądu: monotropizm jest wiarygodną, coraz bardziej zwalidowaną ideą organizującą, ale jego *zasięg wyjaśniający* w każdą komorbidność musi być argumentowany przypadek po przypadku — nie zakładany.

2. Poziom 1 — Bezpośrednie linki: klaster neurodevelopmentalny

2.1 AuDHD i „monotropic split” (*najsilniejszy bezpośredni link*)

Autyzm i ADHD współwystępują znacznie częściej, niż przypadek przewidywałby: ADHD jest obecne w około **30–80%** ludzi autystycznych, a autyzm w około **20–50%** tych z ADHD [5]; metaanaliza podaje stopy objawów ASD w próbach ADHD wokół **21%** [16]; jedno duże studium Medicaid znalazło, że **27%** dorosłych autystycznych bez

niepełnosprawności intelektualnej miało współwystępującą diagnozę ADHD — około 10× stopy ogólnej [17]. Nakładanie jest istotnie genetyczny (~50–72%) [18].

Monotropizm pomaga rozwiązać starą zagadkę: jeśli autyzm to „hyperfokus” a ADHD to „brak uwagi”, dlaczego współwystępują? MQ odpowiada empirycznie — **ludzie z ADHD, zwłaszcza AuDHD, są też wysoce monotropowi** [2][3]. Hyperfocus w ADHD (Grotewiel et al., 2022) jest konceptualnie niemal identyczny z monotropowym tunelem [19]. Ramy „monotropic split” zatem reframują AuDHD nie jako przeciwieństwa, ale jako **niestabilny system konkurujących lub szybko przełączających tuneli uwagi**: mózg żąda głębokiego monotropowego fokusu, ale nie może stabilizować tunelu, produkując znajomą AuDHD oscylację między intensywnym zaangażowaniem, szybkim burnoutem i przewlekłym niedostymulowaniem [19][20].

Zastrzeżenie: mechanizm „wielu konkurujących tuneli” jest *plauzybilny i spójny z danymi MQ*, ale jeszcze nie bezpośrednio testowany jako dynamika; powinien być czytany jako silna hipoteza.

2.2 Autystyczny burnout i pęknięcie tunelu

Autystyczny burnout — przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności i zmniejszona tolerancja — jest coraz bardziej łączony z kumulatywnym kosztem ciągłego przełączania tuneli, maskowania i żądań przewyższających zdolności, z niewystarczającym czasem regeneracji/flow [20][21]. To jest obszar, gdzie monotropizm jest heurystycznie potężny (każde wymuszone przejście to pęknięcie tunelu), choć literatura burnoutu sama w sobie jeszcze dojrzewa i ścieżka monotropizm→burnout jest w dużej mierze kliniczna/z pierwszej osoby, raczej niż eksperymentalnie ugruntowana [20].

2.3 Unikanie żądań i PDA (sporny konstrukt)

Żądanie — „przygotuj się”, „zrób ten formularz” — może być doświadczane jako gwałtowna intruzja w stan flow. To jest intuicyjne monotropowe konto **unikania żądań**. Bardziej specyficzny konstrukt **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, ukuty przez Elizabeth Newson w latach 1980 i teraz często reframowany jako „Pervasive Drive for Autonomy”, opisuje lękowo napędzane zapotrzebowanie na kontrolę i unikanie zwykłych żądań [11][22].

Dwie rzeczy muszą być oddzielone:

- **Zachowanie unikania żądań jest realne i częste** w autyzmie, a monotropowe konto „pęknięcia tunelu” jest rozsądną *mechanistyczną historią* dla paniki i oporu, które produkuje.
- **PDA jako odrębny profil lub podtyp nie jest ugruntowana.** National Autistic Society UK mówi „żadne badanie nie znalazło silnej evidencji dla [PDA] jako odrębnego profilu” [11]; fundamentalne studium Newson było krytykowane za **kołowe rozumowanie i nadinterpretację** (grupy zdefiniowane przez badaczy były potem „badane”) [12][13]; i przeglądy notują uporczywe problemy z definicją, ważnością konstruktów i pomiarem [23]. Przegląd z 2023 jest celnie zatytułowany „*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*” [13].

Więc ramy tekstu źródłowego są w połowie racji: *doświadczenie* (żądanie roztrzaskuje tunel) jest dobrze opisane przez monotropizm; *jednostka diagnostyczna* (PDA) jest sporna i nie powinna być przedstawiana jako uregulowana.

3. Poziom 2 — Pośrednia komorbidność, współdzielony mechanizm

3.1 Anoreksja i restrykcyjne jedzenie

Nakładanie autyzm–anoreksja jest robustne i bidirectionalne: około **20–30%** pacjentów z zaburzeniami odżywiania pokazuje klinicznie znaczące cechy autystyczne, z najwyższymi stopami w anorexia nervosa i ARFID [6][24]; odwrotnie, dorośli autystyczni mają podwyższone stopy zaburzeń odżywiania. Krytycznie, cechy autystyczne są obserwowane **przed** początkiem ZO, więc nakładanie nie jest tylko efektem głodzenia [6].

Najlepiej udokumentowany *mechanistyczny* pomost to **interocepcja** — percepcja wewnętrznych sygnałów ciała (bicie serca, sytość). Atypowa interocepcja jest implikowana w etiologii *zarówno* autyzmu, jak i zaburzeń odżywiania i „może, przynajmniej częściowo, być odpowiedzialna” za ich komorbidność [6]. Ta sama interoceptywna atypikalność podlega **alexytymii** (trudność identyfikowania/werbalizowania emocji), obecnej u ~50% ludzi autystycznych i samej związanej z patologią odżywiania [7][8].

Gdzie monotropizm pasuje (a gdzie nie): jest rozsądne powiedzieć, że monotropowa osoba głęboko w tunelu może *przegapić* sygnały głodu — ale specyficzne twierdzenie tekstu źródłowego, że „monotropizm redukuje interocepcję”, przecenia łańcuch przyczynowy.

Udokumentowana relacja to **autyzm** → **atypowa**

interocepcja/alexetymia → **podatność odżywcza**; monotropizm jest równoległą cechą autyzmu, nie *demonstrowaną przyczyną* różnicy interoceptywnej [6][7]. Śledzenie jedzenia/kalorii może też stać się tunelem samym w sobie, ale to jest mechanizm-plauzybilne raczej niż testowane.

3.2 OCD vs hyper-focus: genuine rozróżnienie

Autyzm i OCD współwystępują istotnie: ~**17%** ludzi autystycznych spełnia kryteria OCD, vs ~1–2% w populacji ogólnej [9]. Mimo powierzchownego podobieństwa (repetatywne zachowanie, sztywność), **afektywny napęd różni się** i to jest dobrze ugruntowane klinicznie:

- **Autystyczne** restrykcyjne/repetatywne zainteresowania i rutyny są typowo **ego-syntoniczne** — przyjemne, samouspokajające, interesowo-napędzane, często regulujące.
- Kompulsje **OCD** są **ego-dystoniczne** — niechciane, lękowo-napędzane, wykonywane, by zneutralizować obawiane wyniki [9][10].

Rozróżnienie tekstu źródłowego jest zatem poprawne i wsparte evidencją i jest potwierdzone bezpośrednio przez samych uczestników autystycznych: w studium jakościowym raportowali, że repetatywne zachowania są „częścią tego, kim są”, podczas gdy objawy OCD „konfliktowały z tym, jak widzą samych siebie” [10]. To samo studium trafnie ramuje współwystępowanie jako „*Autism is the arena and OCD is the lion*” — objawy OCD mogą „porwać” autystyczne specjalne zainteresowania, pompując ich intensywność i dystres [10].

Monotropizm dodaje kontekst (tunel może być *przechwycony* przez treść OCD), ale dyferencjacja spoczywa na osi ego-syntoniczne/dystoniczne, nie na monotropizmie per se.

3.3 Lęk i zaburzenia afektywne (podłoże pod „agorafobią”)

Lęk jest wśród najczęstszych komorbidności autyzmu (jeden przegląd wtórny cytuje ≥ 1 komorbidność psychiatryczną u ~86% ludzi autystycznych) [25]. Dwa punkty mechanizmu mają znaczenie dla

klastra behawioralnego poniżej: (i) **nad-reaktywność sensoryczna** i lęk są powiązane, i przez *warunkowanie kontekstu* produkują **behawioralne unikanie uogólnionych lokalizacji** (restauracje, sklepy, imprezy) [26]; (ii) częste współwystępowanie alexytymii/trudności interoceptywnej oznacza, że stany emocjonalne są często źle etykietowane, napędzając dyfuzyjny lęk [7].

4. Poziom 3 — Klaster behawioralny/funkcjonalny: bałagan, zbieractwo, unikanie, wycofanie społeczne

4.1 Bałagan, „doom piles”, i dyseksekutywna dysfunkcja

Zjawisko jest dobrze poparte: ludzie autystyczni i z ADHD pokazują wysokie stopy dezorganizacji i bałaganu, a najlepiej udokumentowana droga to **dyseksekutywna dysfunkcja** — deficyty w kategoryzacji, podejmowaniu decyzji, planowaniu i pamięci operacyjnej [8][27]. Symptomy zbieractwa są podwyższone tak w ADHD (ze „specjalnym linkiem z brakiem uwagi” [8a]) jak i w autyzmie [8]; w autyzmie specyficznie, praca jakościowa pokazuje, że trudność wyrzucania jest związana z **przywiązaniem zainteresowania i znaczenia**, nie tylko z wartością obiektu [28].

Zastrzeżenie o tekście źródłowym: specyficzne twierdzenie, że bałagan utrzymuje się z powodu „deficytu trwałości obiektu” autystycznego („poza wzrokiem, poza myślami”) **nie jest poparte recenzowaną evidencją**, którą mogłem zlokalizować. Trwałość obiektu jest typowo *nienaruszona lub lepsza* w autyzmie; doświadczenie „poza wzrokiem, poza myślami” lepiej czyta się jako efekt **pamięci operacyjnej/alokacji uwagi** (tunelowaty umysł nie reorientuje się do przechowywanych przedmiotów) niż jako perceptualne niepowodzenie trwałości obiektu. Udokumentowany mechanizm dla bałaganu pozostaje **dyseksekutywna dysfunkcja plus przywiązanie zainteresowania**, co nachodzi na populację monotropową/AuDHD, ale nie jest jedyne „monotropowe” [4][8][28].

4.2 Zachowanie spektrum zbieractwa

Zaburzenie zbieractwa dotyka ~1,5–6% populacji ogólnej, ale jest podwyższone w autyzmie [29]. U dorosłych autystycznych zbieractwopodobna trudność wyrzucania jest często raportowana obok

kognitywnych (eksekutywnych) trudności i silnych przywiązań zainteresowania/znaczenia — przedmioty są węzłami w sieci idei i przyszłej użyteczności, więc wyrzucanie wydaje się stratne [28]. To jest spójne z monotropowym *stylem* (głębokie przetwarzanie obiektów), ale znowu, udokumentowany napęd to EF/przywiązanie, współdzielony przez warunki neurodevelopmentalne [8].

4.3 Agorafobia i ograniczanie „bezpiecznej przestrzeni” (wymaga korekty)

Tekst źródłowy ramuje agorafobiczne uwięzienie w domu jako niemal bezpośredni wynik monotropowy. Dane są bardziej zniuansowane:

- Agorafobia *jest* podwyższona w autyzmie — ~23–25% dorosłych autystycznych (bez NI) vs ~1,3% w populacji ogólnej — **ale jest rzadsza niż fobia społeczna lub GAD**, a efekt koncentruje się na tych bez NI [25].
- Lepiej udokumentowany napęd to **nad-reaktywność sensoryczna + lęk społeczny**, z warunkowanym-kontekstowo unikaniem przytłaczających lokalizacji — tj. zachowanie „bezpiecznej przestrzeni” jest realne, ale jest **wtórne do lęku sensorycznego/społecznego**, nie pierwotnym zjawiskiem monotropowym [25][26].

Więc: monotropizm pomaga wyjaśnić *dłaczego* zewnętrzny świat wydaje się disruptywny (nieprzewidywalny, polytropowy, tunele-rozbijający), ale klasyfikowanie wynikającego uwięzienia jako „agorafobii” specyficznej dla monotropizmu przecenia link. To jest unikanie napędzane lękiem sensorycznym, które *nachodzi na* doświadczenie monotropowe.

4.4 Wycofanie społeczne, info-dumping, i problem podwójnej empatii

Interakcja społeczna jest genuinely polytropowa — wymaga jednoczesnego śledzenia twarzy, tonu, hierarchii, timing'u i niepisanych zasad — więc jest nieproporcjonalnie kosztowna dla systemu monotropowego, punkt spójny z modelem zasobów Goldknopfa [4]. Intuicja tekstu źródłowego jest trafna.

Ale ostrzejsza, *empirycznie poparta* rama dla wynikającej przerwy komunikacyjnej to **problem podwójnej empatii** (Milton, 2012; 2017): trudność jest *bidirectionalna* i relacyjna — „rozłączenie w recprocitości między dwoma różnie usposobionymi aktorami społecznymi” — nie jednokierunkowy deficyt empatii w osobie autystycznej [30]. Praca empiryczna teraz pokazuje, że nie-autystyczni obserwatorzy *i wykrywają, i demonstrują* problem podwójnej empatii w mieszanych interakcjach [31]. „Info-dumping” pasuje naturalnie: to komunikacja szukająca głębi z monotropowego systemu, która zawodzi, gdy partner nie może dorównać głębi — niedopasowanie stylów przetwarzania, nie brak empatii [30][31].

Luka do zaznaczenia: literatura DEP wciąż w dużej mierze wyklucza dzieci autystyczne, ludzi niewerbalnych i ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, więc generalizacja jest ograniczona [32].

5. Granica: gdzie konto monotropowe sięga za daleko

Twierdzenie w ramach źródłowych/laickich	Status evidencji	Lepsze ramy
Monotropizm <i>powoduje</i> cechy autyzmu	Częściowo poparte (MQ; Goldknopf)	Jeden zwalidowany czynnik organizujący spośród kilku; najsilniejszy w autyzmie z sensorycznym [1][4]
AuDHD = „monotropic split” (konkurujące tunele)	Silne + bezpośrednio mierzalne (MQ)	Realny fenotyp uwagi; mechanizm dynamiczny jest poziomą hipotezą [2][3]
PDA jest odrębnym profilem autystycznym	Sporne	Unikanie żądań jest realne; PDA-jako-jednostka brakuje ważności konstruktów [11][12][13]
Monotropizm <i>redukuje interocepję</i> → anoreksja	Pośrednie	Pomost to autyzm → interocepcja/alexytymia → podatność ZO; monotropizm jest równoległy, nie pokazana przyczyna [6][7]
Bałagan z „deficytem trwałości obiektu”	Niepoparte	Dyseksekutywna dysfunkcja + przywiązanie zainteresowania; brak evidencji perceptualnego deficytu trwałości obiektu [4][8][28]

Twierdzenie w ramach źródłowych/laickich	Status evidencji	Lepsze ramy
Agorafobia jako pierwotny wynik monotropowy	Przesadzone	Wtórna do nad-reaktywności sensorycznej + lęku społecznego; rzadsza niż GAD/fobia społeczna [25][26]
OCD vs monotropowe „obsesje” różnią się afektem	Dobrze poparte	Ego-dystoniczne (OCD) vs ego-syntoniczne (autystyczne zainteresowanie); OCD może „porwać” tunele [9][10]
Problem podwójnej empatii wyjaśnia przerwę społeczną	Poparte (ale luki)	Bidirectionalne niedopasowanie; próby stronczą do mówiących dorosłych bez NI [30][31][32]

6. Otwarte pytania

- 1. Dynamiczne testowanie tunelu.** MQ to miara *cechy*. Czy „monotropic split” (konkurujące/niestabilne tunele w AuDHD) jest obserwowalne w czasie-rzeczywistym uwaga/EEG? Largamente nietestowane.
- 2. Strzałka przyczynowa do interocepcji.** Czy monotropowa dystrybucja zasobów *produkuje* interoceptywną atypikalność, czy współdzielą wspólną przyczynę upstream'ową? Obecna evidencja nie może ich oddzielić [6][7].
- 3. Rozstrzygnięcie PDA.** Czy badanie unikania żądań zbieganie się na zwalidowanym, mierzalnym konstrukcie, czy pozostanie sporną kategorią laicką/kliniczną? [11][13]
- 4. Mechanizm bałaganu.** Czy „poza wzrokiem, poza myślami” to efekt pamięci operacyjnej/alokacji (plauzybilne) czy coś innego? Brak dedykowanego studium znaleziony.
- 5. Generalizowalność DEP.** Jak problem podwójnej empatii operuje dla niewerbalnych ludzi autystycznych, dzieci i ludzi ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną? [32]
- 6. Burnout.** Jaki jest specyficzny, testowy wkład monotropowego pęknięcia tunelu w autystyczny burnout vs maskowanie, trauma i przewlekłe żądanie? [20]

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
- Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint). Komentarz/podsumowanie:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; mirror: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — podsumowanie wyników MQ (47 items; N=1.110; autystyczni + ADHD znacząco wyżej): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — ADHD i autyzm komorbidność review (ADHD u ~30–80% ASD; ASD u ~20–50% ADHD; cytuję Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019):
<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50% ludzi autystycznych ma alexytymię, mediowaną deficytami interoceptywnymi.
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] „specjalny link z brakiem uwagi” to własny podtytuł artykułu. Patrz też Drake Institute o ADHD/dyseksekutywnej dysfunkcji:
<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — podsumowanie systematic-review: ~17% ludzi autystycznych spełnia kryteria OCD vs ~1–2%

populacja ogólna; rozróżnienie ego-syntoniczne vs ego-dystoniczne: <https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (jakościowo). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance („żadne badanie nie znalazło silnej evidencji dla [PDA] jako odrębnego profilu"): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA — krytyka kołowego rozumowania Newson (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (zacytowane via Frontiers 2024 studium porównawcze): <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (zacytowane via Psych Scene Hub i Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27% dorosłych autystycznych bez NI miało współwystępujące ADHD (~10× ogół): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — podsumowanie nakładania genetycznego (~50–72%): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-audhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD jako konkurujące tunele; referencje Grotewiel et al. 2022 o ADHD hyperfocus): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest>

[autistic-burnout-monotropism-and-resistance](#) [21] National Autistic Society — What is monotropism? (stany flow; referencje Heasman et al. 2024 "autistic flow theory"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, 1980s; reframing "Pervasive Drive for Autonomy"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (cytuje też Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobia w autyzmie ~23–25% (bez NI) vs ~1,3% ogół; rzadsza niż fobia społeczna/GAD (źródło wtórne, bazując na Helles et al. 2020 i Lugnegård et al. 2012): <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — warunkowanie kontekstu i unikanie. PMC2980623. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (funkcja eksekutywna, podejmowanie decyzji): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (jakościowo). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) rozszerzenie. Podsumowanie: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions

between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia —
Double empathy problem (uznane luki badawcze: dzieci, niewerbalni,
niepełnosprawność intelektualna):
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Uwaga o poziomach evidencji: Poziom 1 = bezpośredni, replikowany
pomiar (MQ; stopy AuDHD); Poziom 2 = replikowana komorbidność z
udokumentowanym współdzielonym mechanizmem; Poziom 3 =
plauzybilna ekstrapolacja, pojedyncze źródło lub sporny konstrukt. Patrz
§5.